TÓM TẮT ĐẠT MỨC 5 – TIÊU CHÍ C6.1
"Hệ thống quản lý điều dưỡng được thiết lập đầy đủ và hoạt động hiệu quả"

Để đạt **mức 5**, bệnh viện phải chứng minh được:
✅ Hệ thống quản lý điều dưỡng được tổ chức đầy đủ
✅ Hoạt động điều dưỡng vận hành thực chất
✅ Có giám sát – đánh giá – cải tiến liên tục
✅ Điều dưỡng tham gia quản lý chất lượng và an toàn NB
✅ Có ứng dụng CNTT và quản trị theo dữ liệu
Tiêu chí C6.1 là nền tảng của toàn bộ hoạt động chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

1. TỔ CHỨC HỆ THỐNG ĐIỀU DƯỠNG ĐẦY ĐỦ

Bắt buộc phải có:
✅ Phòng Điều dưỡng hoặc bộ phận quản lý điều dưỡng
✅ Điều dưỡng trưởng bệnh viện
✅ Điều dưỡng trưởng khoa đầy đủ
✅ Hội đồng Điều dưỡng
✅ Mạng lưới điều dưỡng hoạt động

Có:

- Quy chế hoạt động
- Chức năng nhiệm vụ
- Phân cấp quản lý rõ ràng

2. HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG THỰC CHẤT

Không chỉ "có tên", mà phải:
✅ Họp định kỳ
✅ Có kế hoạch hoạt động
✅ Có giám sát chăm sóc NB
✅ Có kiểm tra khoa phòng
✅ Có biên bản – báo cáo – cải tiến

Điều dưỡng trưởng phải:

- đi buồng
- kiểm tra hồ sơ
- giám sát chăm sóc
- xử lý sự cố điều dưỡng

3. CHUẨN HÓA HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC

Cần đầy đủ:

- Quy định chăm sóc NB
- SOP chăm sóc
- Quy trình bàn giao
- Phân cấp chăm sóc
- Theo dõi NB nguy cơ cao

Hồ sơ chăm sóc:

✅ Ghi đầy đủ
✅ Có lượng giá
✅ Có theo dõi liên tục
✅ Có đánh giá lại

4. GIÁM SÁT – AUDIT – KPI

Muốn mức 5 phải có:

Audit định kỳ ≥ 12 tháng

- hồ sơ chăm sóc
- bàn giao ca
- tuân thủ quy trình

KPI điều dưỡng

Chỉ số	Mục tiêu
Hồ sơ chăm sóc đạt	≥95%
Tuân thủ bàn giao	≥95%
Tuân thủ chăm sóc nguy cơ té ngã	≥95%
Sự cố điều dưỡng	giảm liên tục

Có dashboard theo dõi:

- từng khoa
- từng tháng
- xu hướng cải tiến

5. ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Đây là điểm rất quan trọng mức 5

Điều dưỡng phải tham gia:

✅ phòng ngừa té ngã
✅ loét tỳ đè
✅ nhầm thuốc
✅ nhiễm khuẩn
✅ xác định đúng NB
✅ báo cáo sự cố y khoa

6. ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Cần có:

- Kế hoạch đào tạo năm
- Đào tạo liên tục
- Đánh giá năng lực
- Kiểm tra tay nghề

Có:

✅ đào tạo điều dưỡng mới
✅ đào tạo chuyên khoa
✅ đào tạo an toàn NB
✅ đào tạo giao tiếp

7. ỨNG DỤNG CNTT (ĐIỂM CỘNG MẠNH)

Nên có:

- Hồ sơ chăm sóc điện tử
- Dashboard điều dưỡng
- Barcode người bệnh
- Theo dõi chăm sóc trên HIS
- Nhắc việc điện tử

8. NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC CHĂM SÓC TOÀN DIỆN

Đoàn thường hỏi NB:

- Có được hướng dẫn không?
- Điều dưỡng có giải thích không?
- Có hỗ trợ vệ sinh/dinh dưỡng/vận động không?

Muốn mức 5:

NB phải:

✅ hài lòng
✅ được giáo dục sức khỏe
✅ được theo dõi liên tục
✅ được phản hồi nhanh

9. MINH CHỨNG "ĂN ĐIỂM" MỨC 5

✅ Hội đồng điều dưỡng hoạt động thực
✅ Audit chăm sóc định kỳ
✅ Dashboard KPI điều dưỡng
✅ Hồ sơ chăm sóc điện tử
✅ Báo cáo cải tiến chất lượng
✅ Điều dưỡng tham gia RCA sự cố
✅ Điều dưỡng nghiên cứu khoa học/cải tiến
✅ Tỷ lệ hài lòng NB cao

10. NHỮNG LỖI KHIẾN CHỈ ĐẠT MỨC 3–4

❌ Có tổ chức nhưng hoạt động hình thức
❌ Không có KPI điều dưỡng
❌ Không audit định kỳ
❌ Hồ sơ chăm sóc ghi đối phó
❌ Điều dưỡng trưởng không giám sát thực tế
❌ Không có cải tiến sau kiểm tra
❌ Điều dưỡng không tham gia ATNB

11. CÔNG THỨC NGẮN GỌN ĐẠT MỨC 5 C6.1

Mức 5 =

Hệ thống điều dưỡng đầy đủ

-

Hoạt động thực chất

-

Giám sát liên tục

-

KPI rõ ràng

-

Cải tiến chất lượng

-

Điều dưỡng tham gia ATNB

-

Ứng dụng CNTT

= ĐẠT MỨC 5 C6.1.

1. QUY ĐỊNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

(Mã: QD-C6.1)

QUY ĐỊNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

1. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo người bệnh được chăm sóc liên tục, toàn diện, an toàn và phù hợp với tình trạng bệnh.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho toàn bộ người bệnh nội trú và nhân viên điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên tham gia chăm sóc người bệnh.

3. NỘI DUNG

3.1. Người bệnh được đánh giá nhu cầu chăm sóc ngay khi nhập viện.

3.2. Người bệnh được phân cấp chăm sóc theo mức độ phụ thuộc và tình trạng bệnh.

3.3. Điều dưỡng xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp.

3.4. Chăm sóc được thực hiện liên tục 24/24 giờ.

3.5. Mọi diễn biến bất thường phải được báo bác sĩ điều trị kịp thời.

3.6. Người bệnh nguy cơ cao phải được theo dõi đặc biệt.

3.7. Thực hiện bàn giao người bệnh đầy đủ giữa các ca trực.

3.8. Tất cả hoạt động chăm sóc phải được ghi chép trong hồ sơ bệnh án.

4. TRÁCH NHIỆM

- Điều dưỡng trưởng khoa.
- Điều dưỡng chăm sóc.
- Bác sĩ điều trị.
- Phòng Điều dưỡng.
- Phòng Quản lý chất lượng.

5. KIỂM TRA GIÁM SÁT

Thực hiện định kỳ hàng tháng và báo cáo kết quả theo quy định.

2. SOP CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN

(Mã: SOP-C6.1-01)

SOP-C6.1-01

QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TOÀN DIỆN

1. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo người bệnh được chăm sóc đầy đủ, liên tục và an toàn.

2. QUY TRÌNH

Bước 1. Tiếp nhận người bệnh

- Kiểm tra hồ sơ.
- Nhận định ban đầu.
- Đánh giá dấu hiệu sinh tồn.

Bước 2. Đánh giá nhu cầu chăm sóc

- Tình trạng bệnh.
- Khả năng vận động.
- Dinh dưỡng.
- Nguy cơ té ngã.
- Nguy cơ loét tỳ đè.

Bước 3. Lập kế hoạch chăm sóc

- Xác định vấn đề ưu tiên.
- Xây dựng mục tiêu chăm sóc.
- Lập các can thiệp điều dưỡng.

Bước 4. Thực hiện chăm sóc

- Chăm sóc cơ bản.
- Chăm sóc chuyên khoa.
- Giáo dục sức khỏe.

Bước 5. Theo dõi và đánh giá

- Ghi nhận diễn biến.
- Đánh giá hiệu quả chăm sóc.

- Điều chỉnh kế hoạch khi cần.

Bước 6. Hoàn tất chăm sóc

- Bàn giao đầy đủ.
- Hoàn thiện hồ sơ chăm sóc.

---

3. SOP BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH

(Mã: SOP-C6.1-02)

SOP-C6.1-02

QUY TRÌNH BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH GIỮA CÁC CA TRỰC

1. MỤC ĐÍCH

Đảm bảo thông tin người bệnh được truyền đạt đầy đủ, chính xác và liên tục.

2. THỜI ĐIỂM BÀN GIAO

- Đầu ca trực.
- Cuối ca trực.
- Chuyển khoa.
- Chuyển đơn vị điều trị.

3. NỘI DUNG BÀN GIAO (MÔ HÌNH ISBAR)

I – Identification:

- Họ tên người bệnh.
- Tuổi.
- Chẩn đoán.

S – Situation:

- Tình trạng hiện tại.

B – Background:

- Tiền sử liên quan.

A – Assessment:

- Đánh giá điều dưỡng.
- Các nguy cơ hiện có.

R – Recommendation:

- Các vấn đề cần theo dõi.
- Chỉ định đặc biệt.

4. GHI NHẬN

- Ký xác nhận bàn giao.
- Lưu sổ bàn giao theo quy định.

---

4. QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Cấp I – Chăm sóc đặc biệt

Tiêu chuẩn:

- Người bệnh nặng.
- Hồi sức tích cực.
- Thở máy.
- Nguy cơ tử vong cao.

Theo dõi:

- Liên tục hoặc tối thiểu mỗi 1 giờ.

Cấp II – Chăm sóc tích cực

Tiêu chuẩn:

- Sau phẫu thuật.
- Bệnh nặng ổn định.
- Có nguy cơ biến chứng.

Theo dõi:

- Mỗi 2–4 giờ.

Cấp III – Chăm sóc thông thường

Tiêu chuẩn:

- Tình trạng ổn định.
- Tự phục vụ một phần.

Theo dõi:

- Theo y lệnh và quy định khoa.

Cấp IV – Tự chăm sóc

Tiêu chuẩn:

- Người bệnh ổn định.
- Tự thực hiện được sinh hoạt cá nhân.

Theo dõi:

- Theo kế hoạch chăm sóc thông thường.

---

5. QUY ĐỊNH THEO DÕI NGƯỜI BỆNH NGUY CƠ CAO

Các nhóm người bệnh nguy cơ cao cần lập danh sách và theo dõi riêng:

Nguy cơ té ngã

- Người cao tuổi.
- Rối loạn vận động.
- Sau gây mê.
- Dùng thuốc an thần.

Biện pháp:

- Đánh giá thang điểm té ngã.
- Gắn ký hiệu cảnh báo.
- Hướng dẫn người nhà hỗ trợ.

Nguy cơ loét tỳ đè

- Bất động kéo dài.
- Liệt.
- Suy kiệt.

Biện pháp:

- Đánh giá Braden.
- Trở mình định kỳ.
- Chăm sóc da.

Nguy cơ suy dinh dưỡng

- BMI thấp.
- Ăn uống kém.
- Ung thư, bệnh mạn tính.

Biện pháp:

- Sàng lọc dinh dưỡng.
- Hội chẩn dinh dưỡng.

Nguy cơ diễn biến nặng

- Nhiễm khuẩn nặng.
- Sốc.
- Sau phẫu thuật lớn.

Biện pháp:

- Theo dõi dấu hiệu sinh tồn tăng cường.
- Báo bác sĩ ngay khi có bất thường.

Hồ sơ minh chứng C6.1 nên có đầy đủ

1. Quyết định ban hành quy định chăm sóc người bệnh.
2. SOP chăm sóc người bệnh toàn diện.
3. SOP bàn giao người bệnh (ISBAR).
4. Quy định phân cấp chăm sóc.
5. Phiếu nhận định và kế hoạch chăm sóc.
6. Phiếu phân cấp chăm sóc.
7. Danh sách người bệnh nguy cơ cao.
8. Phiếu theo dõi té ngã.
9. Phiếu theo dõi loét tỳ đè.
10. Phiếu audit chăm sóc người bệnh.

11. Báo cáo KPI chăm sóc hàng tháng/quý.
12. Hồ sơ đào tạo điều dưỡng về chăm sóc toàn diện và bàn giao người bệnh.



---

12. Hồ sơ đào tạo điều dưỡng

Bộ hồ sơ đào tạo nên gồm:

- Quyết định tổ chức đào tạo.
- Kế hoạch đào tạo năm.
- Chương trình đào tạo chăm sóc toàn diện.
- Chương trình đào tạo bàn giao ISBAR.
- Tài liệu đào tạo.
- Danh sách tham dự có ký tên.
- Bài kiểm tra trước/sau đào tạo.
- Biên bản đánh giá sau đào tạo.
- Hình ảnh minh chứng.
- Báo cáo kết quả đào tạo.
- Quyết định công nhận hoàn thành đào tạo (nếu có).
